

**TRATAMENTO DO SORRISO GENGIVAL POR MEIO DA TÉCNICA
MODIFICADA DE REPOSICIONAMENTO LABIAL SUPERIOR: relato de caso
clínico¹**

Gustavo Leal OLIVEIRA²

Jorge Antônio Mansur de MIRANDA³

RESUMO

O sorriso desempenha importante papel na estética facial e nas interações sociais, sendo a exposição gengival excessiva uma condição frequentemente associada ao comprometimento da harmonia estética do sorriso e à insatisfação dos pacientes. O sorriso gengival pode apresentar etiologia multifatorial, envolvendo alterações dentárias, gengivais, musculares e esqueléticas, o que torna fundamental a correta avaliação diagnóstica para definição da abordagem terapêutica mais adequada. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo relatar um caso clínico de tratamento do sorriso gengival por meio da técnica de reposicionamento labial superior. Trata-se de um relato de caso clínico descritivo, fundamentado em revisão da literatura científica acerca do sorriso gengival e das técnicas cirúrgicas utilizadas para seu tratamento. O caso refere-se a um paciente do sexo masculino, apresentando exposição gengival excessiva associada principalmente à hiperatividade do lábio superior, submetido à técnica de reposicionamento labial como alternativa conservadora à cirurgia ortognática. O procedimento foi realizado sem intercorrências cirúrgicas, apresentando adequada evolução pós-operatória e cicatrização satisfatória. A discussão do caso evidenciou concordância entre os resultados clínicos observados e os achados descritos na literatura, especialmente quanto à eficácia da técnica na redução da exposição gengival e melhora da harmonia estética do sorriso. Conclui-se que a técnica de reposicionamento labial modificada constitui alternativa terapêutica eficaz, previsível e minimamente invasiva para casos selecionados de sorriso gengival associados à hiperatividade labial, proporcionando resultados estéticos satisfatórios e elevada aceitação pelo paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Gengiva. Gengivoplastia. Sorriso.

¹ Trabalho apresentado a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica do Curso de Periodontia da Faculdade de Tecnologia do Ipê – FAIPE.

² Estudante do Curso de Periodontia da FAIPE-MG, e-mail: gustavoleal.freitas@gmail.com.

³ Orientador do trabalho. Professor do Curso de Periodontia da FAIPE-MG, e-mail: jamansurmiranda@yahoo.com.br

ABSTRACT

The smile plays an important role in facial aesthetics and social interactions, with excessive gingival display being a condition frequently associated with compromised aesthetic harmony of the smile and patient dissatisfaction. A gummy smile can have a multifactorial etiology, involving dental, gingival, muscular, and skeletal alterations, making a correct diagnostic evaluation fundamental for defining the most appropriate therapeutic approach. Therefore, this study aimed to report a clinical case of treatment of a gummy smile using the upper lip repositioning surgery technique. This is a descriptive clinical case report, based on a review of the scientific literature on gummy smiles and the surgical techniques used for their treatment. The case refers to a male patient presenting with excessive gingival display mainly associated with hyperactivity of the upper lip, who underwent lip repositioning surgery as a conservative alternative to orthognathic surgery. The procedure was performed without surgical complications, showing adequate postoperative evolution and satisfactory healing. The case discussion revealed agreement between the observed clinical results and the findings described in the literature, especially regarding the technique's effectiveness in reducing gingival exposure and improving the aesthetic harmony of the smile. It is concluded that the Lip Repositioning Surgery technique constitutes an effective, predictable, and minimally invasive therapeutic alternative for selected cases of gummy smile associated with lip hyperactivity, providing satisfactory aesthetic results and high patient acceptance.

KEYWORDS: Gums. Gingivoplasty. Smile.

1 INTRODUÇÃO

A estética do sorriso desempenha papel fundamental na percepção da harmonia facial e na autoestima dos indivíduos (Dutra et al., 2011). O sorriso é considerado uma das principais formas de expressão humana e exerce grande influência nas interações sociais, sendo frequentemente associado à atratividade e à confiança. Nesse contexto, a odontologia estética tem buscado compreender e tratar diferentes condições que possam comprometer a harmonia do sorriso, visando proporcionar equilíbrio entre dentes, gengiva e estruturas faciais (Diaspro et al., 2018).

A harmonia do sorriso depende da relação equilibrada entre diversos componentes anatômicos, incluindo dentes, gengiva, lábios e arcadas dentárias (Mestrener et al., 2002; Alberti et al., 2019). A exposição dentária adequada, associada à proporção e ao contorno gengival, constitui fator determinante para a estética facial. Quando há equilíbrio entre essas estruturas, o sorriso é percebido como natural e esteticamente agradável (Antoniazzi et al., 2017).

Durante o sorriso, é fisiologicamente esperado que ocorra uma pequena exposição do tecido gengival (Rocchi Filho, 2020). A literatura odontológica indica que a exposição gengival de até aproximadamente 2 mm é considerada esteticamente aceitável na maioria dos indivíduos. Entretanto, quando essa exposição torna-se excessiva, ultrapassando valores considerados ideais, pode ocorrer comprometimento da harmonia estética do sorriso (Sthapak et al., 2015).

A condição caracterizada pela exposição gengival excessiva durante o sorriso é conhecida como sorriso gengival, ou *Excessive Gingival Display* (EGD) (Faus-Matoses et al., 2018). De modo geral, considera-se sorriso gengival quando há exposição de mais de 2 a 3 mm de gengiva ao sorrir (Sthapak et al., 2015). Embora essa condição não represente necessariamente um problema funcional, ela pode gerar insatisfação estética significativa para muitos pacientes (Silva et al., 2021).

A etiologia do sorriso gengival é multifatorial e pode envolver diferentes fatores anatômicos e funcionais. Entre as principais causas descritas na literatura destacam-se a erupção passiva alterada, o excesso vertical da maxila, o lábio superior curto e a hiperatividade dos músculos responsáveis pela elevação labial.

A erupção passiva alterada caracteriza-se pela permanência da margem gengival em posição mais coronária do que a considerada fisiológica, mesmo após a completa erupção dentária. Nessa condição, a migração apical natural dos tecidos gengivais não ocorre adequadamente, fazendo com que parte da coroa anatômica permaneça recoberta pela gengiva. Como consequência, observa-se redução da coroa clínica aparente, conferindo aos dentes aspecto encurtado e aumentando a quantidade de tecido gengival visível durante o sorriso. O diagnóstico dessa alteração requer criteriosa avaliação clínica e radiográfica, permitindo diferenciar os casos em que há apenas excesso de tecido mole daqueles que apresentam comprometimento da relação entre a margem gengival e a crista óssea alveolar, fator

determinante para o planejamento cirúrgico adequado (Coslet; Vanarsdall; Weisgold, 1977; Alpiste-Illueca, 2011).

Outra importante causa do sorriso gengival é o excesso vertical da maxila, alteração de natureza esquelética caracterizada pelo crescimento exagerado da maxila no sentido vertical. Essa condição promove aumento da distância entre a base nasal e a borda incisal dos dentes superiores, fazendo com que uma quantidade maior de gengiva permaneça exposta durante o sorriso, mesmo na ausência de alterações dentárias ou periodontais. Em pacientes com essa característica, frequentemente observa-se aumento do terço inferior da face, incompetência labial e exposição gengival acentuada tanto em repouso quanto durante o sorriso. Nesses casos, a cirurgia ortognática permanece como tratamento de escolha para correção definitiva da discrepância óssea, embora procedimentos menos invasivos possam ser considerados em situações cuidadosamente selecionadas (Garber; Salama, 1996; Silberberg; Goldstein; Smidt, 2009).

O lábio superior curto também pode contribuir significativamente para o desenvolvimento do sorriso gengival. Essa condição ocorre quando o comprimento do lábio, em repouso, é inferior aos valores considerados fisiológicos, reduzindo naturalmente a cobertura dos incisivos superiores e da gengiva marginal. Dessa forma, mesmo na ausência de alterações ósseas ou musculares, o simples comprimento reduzido do lábio favorece maior exposição gengival durante a fala e, principalmente, durante o sorriso. A correta identificação dessa condição é fundamental para o planejamento terapêutico, uma vez que tratamentos exclusivamente periodontais dificilmente corrigem a alteração estética quando o principal fator etiológico está relacionado às características anatômicas labiais (Seixas et al., 2011; Faus-Matoses et al., 2018).

Entre as causas funcionais do sorriso gengival, destaca-se a hiperatividade dos músculos elevadores do lábio superior, considerada uma das indicações mais clássicas para o reposicionamento labial. Nessa condição, músculos como o levantador do lábio superior, levantador do lábio superior e da asa do nariz, zigomático menor e zigomático maior apresentam contração excessiva durante o sorriso, promovendo elevação exagerada do lábio e consequente exposição excessiva da gengiva. Diferentemente do excesso vertical da maxila, nesses pacientes a estrutura óssea apresenta dimensões compatíveis com a normalidade, sendo o problema decorrente principalmente da dinâmica muscular. Por esse motivo, terapias que

atuam diretamente sobre a movimentação labial, como a aplicação de toxina botulínica e a cirurgia de reposicionamento labial, apresentam elevada previsibilidade clínica quando corretamente indicadas (Polo, 2008; Gabrić Pandurić et al., 2014; Espíndola et al., 2021).

Esses fatores podem atuar isoladamente ou em conjunto, contribuindo para a exposição gengival excessiva durante o sorriso (Espíndola et al., 2021).

Além desses aspectos anatômicos e funcionais, alguns estudos também sugerem a influência de fatores genéticos na ocorrência do sorriso gengival. Características craniofaciais herdadas, como padrões de crescimento maxilar e proporções labiais específicas, podem predispor determinados indivíduos a apresentar maior exposição gengival. Dessa forma, a predisposição genética pode desempenhar papel importante na manifestação dessa condição (Galdino et al., 2021).

Diante da diversidade de fatores etiológicos envolvidos, diferentes abordagens terapêuticas têm sido propostas para o tratamento do sorriso gengival (Geron; Atalia, 2005). A escolha do tratamento depende principalmente da causa da exposição gengival e das características anatômicas do paciente. Entre as opções terapêuticas descritas na literatura encontram-se procedimentos periodontais, intervenções ortodônticas, aplicação de toxina botulínica, cirurgias ortognáticas e técnicas cirúrgicas voltadas ao reposicionamento labial (Espíndola et al., 2021).

Os procedimentos periodontais, como gengivectomia e aumento de coroa clínica, são frequentemente indicados quando a exposição gengival está relacionada a alterações gengivais ou dentárias, como nos casos de erupção passiva alterada. Essas técnicas visam promover o reposicionamento da margem gengival e aumentar a exposição da coroa dentária, contribuindo para uma melhor proporção estética entre dentes e gengiva (Magalhães et al., 2024).

Entretanto, em situações nas quais o sorriso gengival está associado à hiperatividade do lábio superior ou à elevação excessiva dessa estrutura durante o sorriso, procedimentos exclusivamente periodontais podem não ser suficientes para solucionar o problema. Nesses casos, torna-se necessário adotar abordagens terapêuticas que atuem diretamente na dinâmica labial (Espíndola et al., 2021).

A aplicação da toxina botulínica tipo A tem sido amplamente empregada como alternativa minimamente invasiva para o tratamento dos casos de sorriso gengival decorrentes

da hiperatividade dos músculos elevadores do lábio superior. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio temporário da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas da junção neuromuscular, reduzindo a contração muscular e limitando a elevação excessiva do lábio durante o sorriso. Como consequência, observa-se diminuição significativa da exposição gengival, com melhora estética imediata e preservação das estruturas dentárias e periodontais (Polo, 2008; Mazzuco; Hexsel, 2010).

Além de sua utilização como tratamento isolado, estudos recentes demonstram que a toxina botulínica pode atuar como importante recurso auxiliar quando administrada aproximadamente quinze dias antes da cirurgia de reposicionamento labial. Nessa situação, o relaxamento temporário da musculatura elevadora reduz a tensão exercida sobre os tecidos operados, favorecendo a estabilização das suturas, diminuindo a tração durante o período inicial de cicatrização e contribuindo para maior conforto pós-operatório. Essa associação tem sido relacionada à redução da possibilidade de deiscências, menor desconforto funcional e potencial melhora da estabilidade dos resultados cirúrgicos, embora estudos clínicos de longo prazo ainda sejam necessários para estabelecer protocolos padronizados (Humayun et al., 2022).

Entretanto, por apresentar efeito transitório, geralmente com duração entre quatro e seis meses, a toxina botulínica não constitui tratamento definitivo para a hiperatividade muscular, sendo necessária reaplicação periódica para manutenção dos resultados. Dessa forma, em pacientes que buscam correção mais duradoura da exposição gengival, a cirurgia de reposicionamento labial permanece como uma alternativa terapêutica de grande relevância, especialmente quando corretamente indicada e associada a adequado planejamento clínico (Polo, 2008; Faus-Matoses et al., 2018).

Nesse contexto, a técnica de reposicionamento labial superior, tem se destacado como uma alternativa minimamente invasiva para o tratamento do sorriso gengival (Faus-Matoses et al., 2018). Esse procedimento consiste na remoção de uma faixa de mucosa na região vestibular do lábio superior, seguida do reposicionamento do lábio em uma posição mais inferior, limitando sua elevação durante o sorriso e reduzindo a exposição gengival (Gabrić Pandurić et al., 2014).

Embora a técnica convencional de reposicionamento labial apresente resultados clínicos satisfatórios para o tratamento do sorriso gengival associado à hiperatividade do lábio superior, modificações vêm sendo propostas com o objetivo de aumentar a estabilidade dos resultados e

reduzir as taxas de recidiva observadas em alguns casos. Nesse contexto, destaca-se a técnica modificada descrita por Silva, Lazarin e Perussolo (2018), fundamentada em um planejamento cirúrgico individualizado e em refinamentos operatórios destinados a preservar estruturas anatômicas importantes, controlar de forma mais eficiente a ação da musculatura elevadora do lábio superior e minimizar a tensão exercida sobre a linha de sutura. Segundo os autores, essas modificações favorecem o processo de reparo tecidual, aumentam a previsibilidade clínica e contribuem para maior estabilidade estética em médio e longo prazo.

Além das adaptações técnicas, Silva, Lazarin e Perussolo (2018) ressaltam que a previsibilidade da técnica modificada está diretamente relacionada à correta seleção dos pacientes e à identificação precisa da etiologia do sorriso gengival. Dessa forma, a indicação do procedimento deve restringir-se, principalmente, aos casos em que a exposição gengival decorre da hiperatividade da musculatura elevadora do lábio superior, uma vez que alterações predominantemente esqueléticas ou decorrentes de excesso vertical da maxila exigem abordagens terapêuticas distintas. Sob essa perspectiva, a técnica modificada representa não apenas uma evolução operatória do reposicionamento labial convencional, mas uma abordagem baseada na integração entre diagnóstico, planejamento individualizado e execução cirúrgica criteriosa, visando resultados mais previsíveis, estáveis e biologicamente favoráveis.

A técnica de reposicionamento labial modificada tem sido descrita na literatura como uma abordagem eficaz para casos de sorriso gengival associados à hiperatividade labial. Entre suas principais vantagens destacam-se o caráter conservador do procedimento, a relativa simplicidade cirúrgica e o tempo de recuperação geralmente favorável (Faus-Matoses et al., 2018). Entretanto, assim como qualquer intervenção cirúrgica, a técnica apresenta indicações específicas e requer criteriosa seleção dos pacientes para obtenção de resultados satisfatórios (Espíndola et al., 2021).

2 OBJETIVO

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo relatar um caso clínico de tratamento do sorriso gengival por meio da técnica modificada de reposicionamento labial superior, conforme protocolo proposto pelo Prof. Dr. Cléverson de Oliveira Silva, destacando

seus princípios cirúrgicos e sua contribuição para o restabelecimento da harmonia estética do sorriso.

3 JUSTIFICATIVA

Ao se levar em consideração que a estética do sorriso possui grande relevância na percepção da harmonia facial e na construção da autoestima dos indivíduos, passa-se a ser frequentemente notada a sua associação com a confiança e às relações interpessoais. Alterações que comprometem essa harmonia, como o sorriso gengival, podem gerar desconforto estético significativo para muitos pacientes, impactando diretamente sua satisfação com a própria aparência. Nesse contexto, torna-se fundamental que a odontologia contemporânea desenvolva e difunda abordagens terapêuticas capazes de promover resultados estéticos satisfatórios, respeitando as características anatômicas e funcionais de cada paciente.

Dentre as diferentes possibilidades terapêuticas descritas para o tratamento do sorriso gengival, a técnica de reposicionamento labial superior tem ganhado destaque na literatura por apresentar uma abordagem cirúrgica relativamente conservadora quando comparada a procedimentos mais invasivos, como as cirurgias ortognáticas. Nos últimos anos, modificações dessa técnica foram propostas com o objetivo de aumentar a previsibilidade clínica, favorecer a estabilidade dos resultados e reduzir a possibilidade de recidivas. Nesse contexto, destaca-se a técnica modificada descrita por Silva, Lazarin e Perussolo (2018), baseada em refinamentos no planejamento e na execução cirúrgica, buscando otimizar o controle da movimentação labial e promover resultados estéticos mais duradouros. Apesar do crescente interesse por essa abordagem, ainda são escassos os relatos clínicos que demonstrem sua aplicação prática e seus resultados em diferentes situações clínicas.

Dessa forma, a apresentação de casos clínicos envolvendo o tratamento do sorriso gengival por meio da técnica modificada de reposicionamento labial superior torna-se pertinente, uma vez que possibilita a análise detalhada do planejamento, da execução cirúrgica e dos resultados obtidos. Além de contribuir para ampliar o conhecimento científico acerca dessa abordagem, estudos dessa natureza permitem discutir suas indicações, limitações e aplicabilidade clínica, fornecendo subsídios para a tomada de decisão terapêutica e para o aperfeiçoamento das condutas empregadas na reabilitação estética do sorriso, especialmente em casos relacionados à hiperatividade do lábio superior (Silva; Lazarin; Perussolo, 2018).

4 RELATO DO CASO CLÍNICO

Paciente do sexo masculino, identificado pelas iniciais V.F.S., 26 anos, compareceu ao atendimento odontológico apresentando como queixa principal a exposição gengival excessiva durante o sorriso, condição que lhe causava importante desconforto estético e impacto negativo na autoestima.

Durante a análise funcional do sorriso, observou-se acentuada hiperatividade da musculatura elevadora do lábio superior. No sorriso forçado, o paciente apresentava aproximadamente 10 mm de exposição gengival, caracterizando um quadro de sorriso gengival severo. Durante a avaliação clínica inicial, observou-se quadro compatível com sorriso gengival acentuado, caracterizado pela exposição excessiva do tecido gengival maxilar durante a dinâmica do sorriso (Figura 1).

Figura 1 - Foto extraoral inicial



Fonte: Autor (2026)

Ressalta-se que a avaliação clínica, associada aos exames complementares, permitiu descartar alterações esqueléticas significativas, indicando que a principal etiologia da exposição gengival estava relacionada à hipermobilidade do lábio superior, condição compatível com a indicação da técnica modificada de reposicionamento labial.

Ao exame clínico, observou-se hiperatividade do lábio superior, com exposição gengival aproximada de 10 mm durante o sorriso forçado, característica compatível com sorriso gengival de origem muscular. A partir dessa avaliação clínica foi estabelecido o planejamento cirúrgico individualizado.

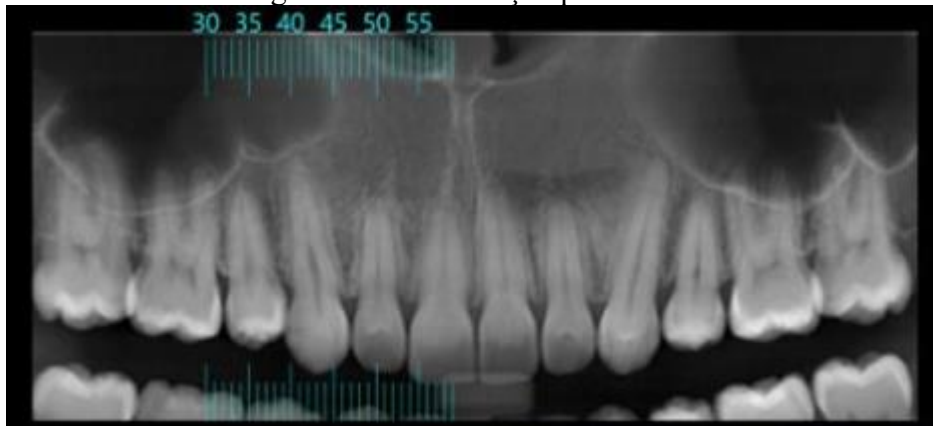
Durante a anamnese, o paciente relatou não possuir doenças sistêmicas, não fazer uso contínuo de medicamentos e não apresentar histórico de alergias medicamentosas. A avaliação clínica intraoral e extraoral não evidenciou alterações patológicas relevantes que contraindicassem a realização do procedimento cirúrgico. Como parte do planejamento pré-operatório, foram solicitados exames de imagem, incluindo tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional (Figura 2) e reconstrução panorâmica (Figura 3), com o objetivo de auxiliar na análise anatômica das estruturas maxilofaciais e no planejamento cirúrgico do caso.

Figura 2 - Reconstrução 3D



Fonte: Autor (2026)

Figura 3 - Reconstrução panorâmica



Fonte: Autor (2026)

Os exames de imagem não evidenciaram alterações ósseas significativas, assimetrias maxilofaciais relevantes ou condições patológicas associadas que justificassem abordagem cirúrgica ortognática.

Assim, após avaliação clínica e imaginológica, observou-se que o sorriso gengival apresentado pelo paciente estava associado principalmente à elevação excessiva do lábio superior durante o sorriso. E, considerando as características clínicas observadas, optou-se pela realização da técnica modificada de reposicionamento labial superior, visando reduzir a exposição gengival excessiva sem a necessidade de procedimentos mais invasivos, como a cirurgia ortognática.

Como parte do protocolo terapêutico adotado, realizou-se a aplicação de toxina botulínica tipo A quinze dias antes da intervenção cirúrgica (Figura 4). Realizada por outro cirurgião-dentista, como medida complementar para redução temporária da hiperatividade dos músculos elevadores do lábio superior e otimização do planejamento cirúrgico. A aplicação foi realizada na região anatômica conhecida como Y-point, envolvendo os músculos levantador do lábio superior e da asa do nariz (*levator labii superioris alaeque nasi*) e zigomático menor. De acordo com as informações fornecidas pelo profissional responsável, foi utilizado aproximadamente um terço do frasco previamente reconstituído de toxina botulínica. Entretanto, não foi possível obter o registro da quantidade exata de unidades (U) administradas.

Figura 4 – Aplicação pré-operatória de toxina botulínica tipo A na musculatura elevadora do lábio superior



Fonte: Autor (2026)

O procedimento de administração da toxina botulínica teve como finalidade promover o relaxamento temporário da musculatura elevadora do lábio superior, reduzindo sua hiperatividade e diminuindo a tensão exercida sobre os tecidos durante o ato operatório e no período inicial de cicatrização. Essa conduta visou favorecer maior estabilidade do reposicionamento labial, proporcionar melhor adaptação dos tecidos e contribuir para a previsibilidade dos resultados pós-operatórios.

No dia da cirurgia, após confirmação do adequado efeito clínico da toxina botulínica, o procedimento foi realizado sob anestesia local infiltrativa bilateral. Foram utilizados quatro tubetes anestésicos contendo cloridrato de lidocaína associado à epinefrina, administrados bilateralmente na região de fundo de vestíbulo maxilar, próxima à região da musculatura elevadora do lábio superior. Posteriormente, durante a etapa de sutura, foi necessária complementação anestésica com meio tubete adicional devido ao desconforto relatado pelo paciente no momento da manipulação tecidual.

Após antissepsia intraoral e anestesia infiltrativa local, procedeu-se à demarcação da área cirúrgica na mucosa vestibular do lábio superior utilizando marcador cirúrgico estéril. Considerando que o paciente apresentava aproximadamente 10 mm de exposição gengival durante o sorriso forçado, delimitou-se uma faixa elíptica de mucosa com aproximadamente 10 mm de altura, estendendo-se bilateralmente de acordo com a amplitude do sorriso. A marcação teve como referência a junção mucogengival, sendo preservado o freio labial superior, conforme proposta da técnica modificada de reposicionamento labial (Figura 5).

Figura 5 – Demarcação cirúrgica



Fonte: Autor (2026)

Em seguida, realizaram-se duas incisões paralelas de espessura parcial, delimitando a faixa de mucosa previamente marcada, unidas por incisões laterais nas extremidades. O tecido foi cuidadosamente removido, preservando-se o periósteo e as estruturas anatômicas adjacentes. Após a excisão da faixa de aproximadamente **10 mm de mucosa**, promoveu-se a aproximação da mucosa labial à junção mucogengival mediante suturas interrompidas, reduzindo a profundidade do vestíbulo e restringindo a excursão do lábio superior durante o sorriso. A preservação do freio labial permitiu a manutenção da linha média e favoreceu o adequado posicionamento dos tecidos durante a cicatrização, contribuindo para maior previsibilidade estética do procedimento (Figura 6).

Figura 6 – Descolamento tecidual



Fonte: Autor (2026)

Após a remoção da faixa de mucosa previamente delimitada, realizou-se o reposicionamento dos tecidos, promovendo a aproximação da mucosa labial em posição mais inferior (Figura 7). O objetivo da técnica consistiu em limitar parcialmente a elevação do lábio superior durante o sorriso, reduzindo, consequentemente, a exposição gengival excessiva.

Figura 7 – Reposicionamento de tecidos + sutura



Fonte: Autor (2026)

A síntese cirúrgica foi realizada utilizando fio de sutura de *nylon* azul extrafino, sendo empregados três fios durante o procedimento. A sutura foi executada cuidadosamente com o intuito de favorecer adequada estabilização tecidual e melhor reparo cicatricial da região operada.

No pós-operatório, prescreveu-se a dexametasona 4 mg, utilizada de 12 em 12 horas durante 3 dias, visando controle inflamatório pós-cirúrgico. O paciente também recebeu orientações referentes aos cuidados pós-operatórios, incluindo higienização adequada da região operada, controle dos movimentos labiais e cuidados alimentares durante o período inicial de cicatrização.

Durante o acompanhamento clínico pós-operatório, não foram observadas intercorrências cirúrgicas ou complicações infecciosas. O processo de cicatrização ocorreu de maneira satisfatória, apresentando adequada reparação tecidual e evolução clínica favorável (Figura 8).

Figura 8 – Cicatrização da sutura/cirurgia



Fonte: Autor (2026)

Ao final do acompanhamento, verificou-se redução significativa da exposição gengival durante o sorriso, promovendo maior harmonia entre lábio, gengiva e elementos dentários. O resultado obtido demonstrou melhora estética expressiva e importante satisfação do paciente em relação ao procedimento realizado, evidenciando a eficácia da técnica de reposicionamento

labial superior como alternativa terapêutica conservadora para casos selecionados de sorriso gengival (Figura 9).

Figura 9 – Foto extraoral final



Fonte: Autor (2026)

Para uma melhor visualização do resultado, a Figura 10 traz a comparação de pré-cirúrgico, pós-cirúrgico com 15 dias e com 10 meses, respectivamente.

Figura 10 - Comparação: A) pré-cirúrgico, B) pós-cirúrgico com 15 dias e C) pós-cirúrgico com 10 meses



Fonte: Autor (2026)

5 DISCUSSÃO

O sorriso exerce importante influência na percepção da estética facial e na autoestima dos indivíduos, sendo considerado um dos principais elementos de expressão facial e interação social. Nesse contexto, alterações relacionadas à exposição gengival excessiva podem ocasionar desconforto estético significativo, levando muitos pacientes à busca por tratamentos voltados à harmonização do sorriso. Conforme discutido por Dutra et al. (2011), a estética do sorriso encontra-se diretamente relacionada ao equilíbrio entre dentes, gengiva e lábios, corroborando os achados observados no presente caso clínico, no qual o paciente apresentava exposição gengival acentuada associada à elevação excessiva do lábio superior.

No presente caso, o planejamento cirúrgico foi realizado de forma individualizada, considerando a exposição gengival de aproximadamente **10 mm** observada durante o sorriso forçado. Em conformidade com as recomendações descritas na literatura, delimitou-se uma faixa de aproximadamente **10 mm de mucosa vestibular** para excisão, respeitando os limites anatômicos do vestíbulo e as características clínicas do paciente. Embora diferentes métodos possam ser utilizados para definir a extensão da remoção tecidual, o planejamento deve sempre estabelecer uma relação entre o grau de exposição gengival e a quantidade de mucosa a ser removida, evitando tanto a subcorreção quanto a remoção excessiva de tecido. Dessa forma, a individualização da técnica representa um dos principais fatores associados à previsibilidade estética e à estabilidade dos resultados obtidos com o reposicionamento labial (Tatakis, 2022; Silva; Tatakis, 2023).

Outro aspecto importante refere-se à preservação do freio labial superior durante o procedimento. Essa modificação técnica tem sido recomendada por favorecer a manutenção da linha média labial, reduzir a morbidade pós-operatória e contribuir para maior estabilidade dos tecidos, sem comprometer a eficácia do reposicionamento labial. Dessa forma, a técnica empregada no presente caso está de acordo com as modificações contemporâneas descritas na literatura para otimização dos resultados cirúrgicos (Silva; Tatakis, 2023).

A literatura demonstra que o sorriso gengival possui etiologia multifatorial, podendo estar relacionado a alterações dentárias, gengivais, esqueléticas ou musculares (Espíndola et al., 2021). No presente caso, os exames clínicos e imaginológicos não evidenciaram alterações ósseas severas ou discrepâncias maxilares importantes que justificassem a indicação de cirurgia

ortognática. Dessa forma, os achados clínicos reforçaram a hipótese de hiperatividade labial como principal fator etiológico associado à exposição gengival excessiva apresentada pelo paciente.

Outro aspecto relevante observado no presente caso refere-se ao planejamento cirúrgico prévio associado à avaliação imaginológica detalhada. A utilização de tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional permitiu análise anatômica mais precisa das estruturas maxilofaciais, contribuindo para melhor planejamento da abordagem terapêutica. Embora o diagnóstico do sorriso gengival seja predominantemente clínico, exames de imagem podem auxiliar na exclusão de alterações esqueléticas importantes e na definição do tratamento mais adequado para cada caso.

Segundo Gabrić Pandurić et al. (2014), a técnica de reposicionamento labial modificada apresenta-se como alternativa minimamente invasiva para casos de sorriso gengival associados à hiperatividade do lábio superior, atuando diretamente na limitação da elevação labial durante o sorriso. Tal descrição corrobora diretamente a conduta adotada neste relato, uma vez que a escolha pelo reposicionamento labial superior objetivou reduzir a exposição gengival sem a necessidade de intervenções cirúrgicas mais invasivas.

Além do procedimento cirúrgico, o protocolo terapêutico adotado neste caso incluiu a aplicação pré-operatória de toxina botulínica tipo A como medida adjuvante. A aplicação foi realizada quinze dias antes da cirurgia, na região anatômica denominada *Y-point*, que corresponde ao ponto de ação dos principais músculos elevadores do lábio superior, incluindo o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz (*levator labii superioris alaeque nasi*) e o zigomático menor. Estudos recentes demonstram que a associação da toxina botulínica ao reposicionamento labial pode reduzir temporariamente a hiperatividade muscular durante o período inicial de cicatrização, diminuindo a tensão sobre a linha de sutura e contribuindo para maior estabilidade dos resultados cirúrgicos, especialmente quando aplicada previamente ao procedimento. (Silva; Tatakis, 2023).

A cirurgia ortognática é frequentemente descrita como uma das abordagens terapêuticas indicadas para casos de sorriso gengival associados ao excesso vertical de maxila. Entretanto, apesar de sua efetividade, trata-se de procedimento de maior complexidade cirúrgica, maior morbidade pós-operatória e período de recuperação mais prolongado. Nesse sentido, Faus-Matoses et al. (2018) destacam que a técnica de reposicionamento labial superior vem ganhando

destaque justamente por apresentar caráter mais conservador, menor invasividade e recuperação clínica geralmente mais favorável quando adequadamente indicada. Tal perspectiva reforça a importância da correta seleção do paciente para obtenção de resultados satisfatórios.

Durante o procedimento cirúrgico, optou-se pela utilização da lâmina cirúrgica de bisturi 15 C de ponta menor, instrumento frequentemente empregado em procedimentos periodontais e cirurgias de tecidos moles devido ao seu formato reduzido e maior delicadeza de corte. Diferentemente de lâminas convencionais, a lâmina 15C apresenta extremidade mais fina e angulada, proporcionando maior precisão em incisões delicadas e melhor controle cirúrgico em regiões anatômicas restritas. Tal característica mostrou-se particularmente importante no presente caso, considerando a necessidade de remoção controlada da faixa de mucosa vestibular e preservação adequada dos tecidos adjacentes.

Além disso, a utilização de materiais específicos para sutura também contribuiu para adequada estabilização tecidual no pós-operatório. A síntese realizada com fio *de nylon* azul extrafino favoreceu melhor adaptação dos tecidos e adequado reparo cicatricial, aspectos considerados fundamentais para o sucesso estético da técnica de reposicionamento labial superior. Segundo Espíndola et al. (2021), a estabilidade dos tecidos no período pós-operatório representa fator importante para manutenção dos resultados obtidos e redução de possíveis recidivas.

No presente relato, não foram observadas intercorrências cirúrgicas ou complicações infecciosas durante o acompanhamento pós-operatório, sendo observada evolução cicatricial satisfatória e importante redução da exposição gengival. Tal resultado corrobora os achados descritos por Faus-Matoses et al. (2018), que relatam elevada previsibilidade clínica e bons resultados estéticos quando a técnica é corretamente indicada e executada.

Embora a técnica de reposicionamento labial modificada apresente resultados favoráveis, a literatura ressalta que sua indicação deve ser cuidadosamente individualizada, principalmente devido à possibilidade de recidiva parcial em alguns casos. Dessa forma, torna-se fundamental adequada avaliação etiológica do sorriso gengival, bem como criterioso planejamento cirúrgico, fatores que influenciam diretamente a estabilidade e longevidade dos resultados obtidos.

Diante dos resultados observados neste caso clínico, foi possível verificar que o reposicionamento labial superior constituiu alternativa terapêutica eficaz e conservadora para o

tratamento do sorriso gengival apresentado pelo paciente, promovendo melhora estética significativa sem necessidade de abordagem ortognática. Assim, os achados clínicos observados reforçam a relevância da técnica como opção viável para casos selecionados de exposição gengival excessiva associada à hiperatividade labial.

6 CONCLUSÃO

Conclui-se que o sorriso gengival representa uma condição de importante impacto estético e psicossocial, exigindo diagnóstico etiológico criterioso e planejamento individualizado para a definição da abordagem terapêutica mais adequada. No presente caso clínico, a técnica modificada de reposicionamento labial superior, associada ao planejamento cirúrgico individualizado e à aplicação pré-operatória de toxina botulínica como terapia adjuvante, demonstrou-se uma alternativa terapêutica eficaz, conservadora e minimamente invasiva para o tratamento da exposição gengival excessiva decorrente da hiperatividade do lábio superior.

A preservação do freio labial superior, a remoção planejada da faixa de mucosa compatível com a exposição gengival apresentada pelo paciente e a adequada execução da técnica contribuíram para a obtenção de resultados estéticos satisfatórios, com boa evolução cicatricial, ausência de intercorrências pós-operatórias e elevado grau de satisfação do paciente durante o período de acompanhamento.

Dessa forma, os achados deste relato corroboram as evidências disponíveis na literatura ao demonstrar que o reposicionamento labial superior constitui uma alternativa viável à cirurgia ortognática em casos criteriosamente selecionados. Além disso, reforçam a importância do planejamento individualizado, da correta seleção dos pacientes e da adoção de modificações técnicas contemporâneas para favorecer a previsibilidade clínica, a estabilidade dos resultados e a obtenção de desfechos estéticos mais satisfatórios.

REFERÊNCIAS

ALBERTI, G. T.; MIOSO, F. V.; CESERO, L. Reabilitação estética de paciente com sorriso gengival: relato de caso clínico. *Revista Odontológica de Araçatuba*, v. 40, n. 1, p. 19-24, jan./abr, 2019.

ALPISTE-ILLUECA, F. Altered passive eruption (APE): a little-known clinical situation. *Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal*, Valencia, v. 16, n. 1, p. e100-e104, 2011

ANTONIAZZI, R. P.; FISCHER, L. S.; BALBINOT, C. E. A.; ANTONIAZZI, S. P.; SKUPIEN, J. A. Impact of excessive gingival display on oral health-related quality of life in a Southern Brazilian young population. *Journal of Clinical Periodontology*, v. 44, n. 10, p. 996–1002, 2017. DOI: 10.1111/jcpe.12753.

COSLET, J. G.; VANARSDALL, R. L.; WEISGOLD, A. S. Diagnosis and classification of delayed passive eruption of the dentogingival junction in the adult. *Alpha Omegan*, Chicago, v. 70, n. 3, p. 24-28, 1977.

DIASPRO, A.; CAVALLINI, M.; PATRIZIA, P.; SITO, G. Gummy smile treatment: proposal for a novel corrective technique and a review of the literature. *Aesthetic Surgery Journal*, v. 38, n. 12, p. 1330–1338, 2018.

DUTRA, M. B.; RITTER, D. E.; BORGATTO, A.; DERECH, C. D.; ROCHA, R.; Influência da exposição gengival na estética do sorriso. *Dental Press J. Orthod.*, v. 16, n. 5, out., 2011.

FAUS-MATOSES, I.; MARTÍ-FRÍAS, J.; FAUS-MATAS, V.; FAUS-LLÁCER, V. J. Lip repositioning technique for the treatment of excessive gingival display: a systematic review. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*, Hoboken, v. 30, n. 2, p. 101-112, 2018.

GABRIĆ PANDURIĆ, D. et al. Surgical treatment of excessive gingival display using lip repositioning technique. *Acta Clinica Croatica*, Zagreb, v. 53, p. 233-240, 2014.

GALDINO, D. A.; MACEDO BERNARDINO, Í.; NASCIMENTO BARBOSA, D.; FERREIRA, I. J.; SILVA, F. A.; SILVA, B. D.; COSTA, L. G. C. Correção do sorriso gengival através do aumento de coroa clínica usando a técnica flapless: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5, e10210512753, 2021.

GARBER, D. A.; SALAMA, M. A. The aesthetic smile: diagnosis and treatment. *Periodontology 2000*, Copenhagen, v. 11, p. 18-28, 1996.

GERON, S.; ATALIA, W. Influence of sex on the perception of oral and smile esthetics with different gingival display and incisal plane inclination. *The Angle Orthodontist*, v. 75, n. 5, p. 778–784, 2005.

MAGALHÃES, R. M.; CARRIAS, R. S.; SILVA, V. C. S.; MATOS, K, M.; SILVA, J. C.; SILVA, J. C.; et al. Cirurgia de aumento de coroa clínica em periodontia com fins protéticos e estéticos: revisão de literatura. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 5, p. 1001-1014, 2024.

MAZZUCO, R.; HEXSEL, D. Gummy smile and botulinum toxin: a new approach based on the gingival exposure area. *Journal of the American Academy of Dermatology*, New York, v. 63, n. 6, p. 1042-1051, 2010.

MESTRENER, S. R.; KOMATSU, J. Recuperação da linha do sorriso utilizando procedimentos cirúrgico e restaurador. *JBD – Jornal Brasileiro de Dentística*, v. 1, n. 3, p. 226–230, 2002.

POLO, M. Botulinum toxin type A in the treatment of excessive gingival display. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, St. Louis, v. 133, n. 2, p. 195-203, 2008.

ROCCHI FILHO, R. B. Sorriso gengival: definições, diagnóstico e métodos de tratamento. 2020. 33p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em odontologia), Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 2020.

SEIXAS, M. R.; COSTA-PINTO, R. A.; ARAÚJO, T. M. Checklist of aesthetic features to consider in diagnosing and treating excessive gingival display (gummy smile). *Dental Press Journal of Orthodontics*, Maringá, v. 16, n. 2, p. 131-157, 2011.

SILBERBERG, N.; GOLDSTEIN, M.; SMIDT, A. Excessive gingival display – etiology, diagnosis and treatment modalities. *Quintessence International*, Berlin, v. 40, n. 10, p. 809-818, 2009.

SILVA, Cléverson de Oliveira; LAZARIN, Rafael; PERUSSOLO, Jeniffer. Tratamento do sorriso gengival por meio da técnica de reposicionamento labial modificada. In: *Atualidades em Odontologia*. Maringá: Editora Uningá, 2018. cap. 7, p. 268–308.

SILVA, H. F. V.; LEITE, R. B.; OLIVEIRA, M. S. G.; LEITE, J. V. C.; OLIVEIRA FELISMINO, C. M.; ARAUJO CRUZ, M. E.; SANTOS, A.; GUSMÃO, G. P.; LIMA, L. N. C. Avaliação de diferentes técnicas para correção do sorriso gengival: revisão da literatura. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5, e54510515092, 2021.

SPÍNDOLA, L. C. P., RIBEIRO, E. D. P., ARAÚJO, E. M. (2021). Lip repositioning surgery for gummy smile correction: Literature review and case report. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5, e5210514667, 2021.

STHAPAK, U.; KATARIA, S.; CHANDRASHEKAR, K. T.; MISHRA, R.; TRIPATHI, V. D. Management of excessive gingival display: lip repositioning technique. *Journal of the International Clinical Dental Research Organization*, v. 7, n. 2, p. 151, 2015.

TATAKIS, D. N. Lip repositioning techniques and modifications. *Dental Clinics of North America*, v. 66, n. 3, p. 421-438, 2022.

TATAKIS, D. N.; SILVA, C. O. Contemporary treatment techniques for excessive gingival display caused by altered passive eruption or lip hypermobility. *Journal of Dentistry*, v. 138, 2023. Art. 104711.